

INFILTRACIONES EN PIE

Noelia Fernández Valverde, Marco Piro, Nieves Gómez González, Juan José González Fernández.

INDICACIÓN 1: TALALGIA

Distinguimos en ella dos patologías principales

Fascitis plantar

- Inflamación de la inserción posterior de la fascia plantar por sobrecarga de tensión.
- Diagnóstico: dolor intenso en zona plantar y medial del talón presente al empezar la deambulación y asociado a cambios posturales (levantarse y andar).
- Exploración física: dolor con dorsiflexión de los dedos y a la palpación del talón.

Espolón calcáneo

- Formación ósea a nivel sub o retrocalcáneo que provoca dolor y que está producida por microtraumatismos o inflamaciones de repetición.
- Puede ser asintomático.
- **Diagnóstico:**
 - Dolor súbito o paulatino en talón secundario a una deambulación prolongada (cojea)
 - El diagnóstico de certeza es radiológico (proyección lateral de ambos pies), siendo en la mayoría de los casos un hallazgo casual.
- **Exploración física:**
 - Dolor a la palpación profunda del talón en el lugar de aparición de la exostosis.

Descripción de la técnica

Paciente en decúbito supino con el pie cruzado sobre la otra pierna o en posición neutra y rotación externa del pie:

- Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento
- Lavado de zona con antiséptico en sentido horario hacia fuera
- Marcar punto de entrada por delante del punto de máximo dolor
- Anestesia local con aguja subcutánea y aspiración previa
- Punto de infiltración: borde anterointerno del talón próximo a la zona de apoyo
- Dirección de aguja: paralela al plano de apoyo hacia el centro del talón
- Inyección lenta en abanico.

Material para desarrollar la técnica

- Guantes
- Aguja intramuscular 21G (verde)
- Jeringa de 5 o 10 ml
- Mezcla de infiltración (1:1) de:
 - Corticoide: Triancinolona 40mg/1ml
 - Anestésico: Mepivacaína 2%



INDICACIÓN 2: METATARSALGIA O NEUROMA DE MORTON

Compresión del nervio digital plantar a nivel del segundo o tercer espacio intermetatarsiano por el ligamento intermetatarsiano transverso y las cabezas de los metatarsianos, que produce fibrosis perineural.

Diagnóstico

Dolor lancinante en relación con la marcha en 2º, 3º ó 4º dedos, según el espacio afecto, asociado a alteraciones sensitivas (disestesias) de los mismos.

Más prevalente en mujeres que utilizan zapatos de punta estrecha y tacón alto. La RM y el electromiograma confirman el diagnóstico.

Exploración física

Dolor en antepie irradiado a los dedos con la compresión lateral de las cabezas de los metatarsianos.

Descripción de la técnica

Paciente en decúbito supino con rodilla flexionada y pie en flexión y apoyo plantar:

- Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento
- Lavado de zona con antiséptico en sentido horario hacia fuera
- Marcar punto de entrada por delante del punto de máximo dolor o en el lugar del neurinoma
- Anestesia local con aguja subcutánea y aspiración previa
- Punto de infiltración: a nivel de 2º ó 3º espacio intermetatarsiano, desde dorsal hacia plantar, atravesando el ligamento trasverso intermetatarsiano

- Dirección de aguja: perpendicular al plano cutáneo
- Inyección a unos milímetros del punto doloroso (parestesia).

Material para desarrollar la técnica

- Guantes
- Aguja intramuscular 25G (naranja)
- Jeringa de 5 o 10 ml
- Mezcla de infiltración (1:1) de:
 - Corticoide: Triancinolona 40mg/1ml
 - Anestésico: Mepivacaína 2%



BIBLIOGRAFÍA

- Navarro Massip, L., Rivero Franco, I. Infiltraciones (II). AMF 2010;6(3):147-152.
- Sanfelix Genovés, J., Giner Ruiz, V., Fluixá Carrascosa, C., Millán Soria, J., Fuertes Fortea, A., Manual de infiltraciones en Atención Primaria. Generalitat. Conselleria de Sanitat. 2007;47-49.
- Vidal Fuentes, J. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos. FAES FARMA. 2015.